

سوال ۱

سوال: کدامیک از خصوصیات درد التهابی است؟

(۱) با فعالیت بهتر می شود.

(۲) خشکی صبحگاهی کمتر از نیم ساعت است.

(۳) وضعیت بدون درد وجود دارد.

(۴) با استراحت بهتر می شود.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ۱ (صحیح):** یکی از ویژگی‌های بارز کمردرد التهابی (IBP) که مشخصه اسپوندیلوآرتریت است، بهبود درد و خشکی با ورزش یا فعالیت است.
- **گزینه ۲ (غلط):** خشکی صبحگاهی در دردهای التهابی معمولاً طولانی‌مدت (بیش از ۳۰ دقیقه) است. خشکی کمتر از ۳۰ دقیقه مشخصه دردهای مکانیکی است.
- **گزینه ۳ (غلط):** درد التهابی معمولاً مزمن (بیش از ۳ ماه) است و حالت کاملاً بدون درد کمتر وجود دارد.
- **گزینه ۴ (غلط):** درد التهابی با استراحت و عدم فعالیت بدتر می‌شود، در حالی که دردهای مکانیکی با استراحت بهبود می‌یابند.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: کمردرد التهابی در برابر کمردرد مکانیکی): کمردرد التهابی (IBP) یکی از کلیدی‌ترین علائم برای مشکوک شدن به اسپوندیلو آرتريت محوری (axSpA) است و افتراق آن از کمردرد شایع مکانیکی اهمیت زیادی دارد. ویژگی‌های اصلی کمردرد التهابی عبارتند از:

- **سن شروع:** معمولاً قبل از ۴۰-۴۵ سالگی آغاز می‌شود.
- **نحوه شروع:** شروع آن تدریجی و موزیانه است (Insidious).
- **مدت زمان:** مزمن است و بیش از ۳ ماه طول می‌کشد.
- **خشکی صبحگاهی:** طولانی‌مدت است و بیش از ۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد.
- **تأثیر فعالیت:** درد و خشکی با ورزش و فعالیت بهبود می‌یابد.
- **تأثیر استراحت:** درد و خشکی با استراحت و بی‌حرکتی بدتر می‌شود.
- **درد شبانه:** درد در نیمه دوم شب شایع است و بیمار را از خواب بیدار می‌کند. بیمار پس از بیدار شدن و راه رفتن احساس بهبودی می‌کند.
- **پاسخ به NSAIDs:** معمولاً به دوز کامل داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) پاسخ خوبی می‌دهد (بیش از ۵۰٪ بهبودی در ۴۸ ساعت).

سوال ۲

سوال: تست HLAB27 در کدام بیماری مثبت میشود؟ (۱) لوپوس (۲) اسکلرودرمی (۳) اسپوندیلیت انکیلوزان (۴) آرتروز

پاسخ صحیح: گزینه ۳

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ۳ (صحیح):** ژن HLA-B27 قوی‌ترین عامل خطر ژنتیکی برای اسپوندیلوآرتريت‌ها، به خصوص اسپوندیلیت آنکیلوزان (که نوعی اسپوندیلو آرتريت محوری رادیوگرافیک است)، محسوب می‌شود. این ژن در ۸۵-۹۰٪ بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان (r-axSpA) مثبت است.
- **گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ (غلط):** فایل درسنامه هیچ اشاره‌ای به ارتباط HLA-B27 با بیماری‌های لوپوس، اسکلرودرمی یا آرتروز نکرده و تمام بحث در مورد این ژن محدود به خانواده اسپوندیلوآرتريت‌ها است.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: نقش HLA-B27 در HLA-B27: SpA): یک آلل از دسته MHC کلاس I است که بر روی سطح تمام سلول‌های هسته‌دار بیان می‌شود و می‌تواند پپتیدها را به سلول‌های T سایتوتوکسیک (CD8+) ارائه دهد.

• اهمیت بالینی:

- قوی‌ترین فاکتور خطر ژنتیکی برای SpA، به خصوص نوع محوری (axSpA) است.
- در ۸۵-۹۰٪ بیماران r-axSpA (اسپوندیلیت آنکیلوزان) و ۵۰-۹۰٪ بیماران nr-axSpA مثبت است.
- این در حالی است که شیوع آن در جمعیت سالم قفقازی تنها حدود ۵٪ است.

• محدودیت‌ها:

- داشتن این ژن به تنهایی برای ایجاد بیماری کافی نیست؛ تنها بخش کوچکی از افراد HLA-B27 مثبت به بیماری مبتلا می‌شوند.
- ریسک ابتلا در بستگان درجه اول یک بیمار AS که HLA-B27 مثبت هستند، تنها ۲۰٪ است که نشان‌دهنده نیاز به عوامل محرک دیگر (محیطی) است.

• مکانیسم‌های احتمالی در ایجاد بیماری:

- **تأثیر بر میکروبیوم روده:** به نظر می‌رسد HLA-B27 ترکیب باکتری‌های روده را تغییر می‌دهد (دیسبیوز) و این تغییر ممکن است به شروع بیماری کمک کند.
- **افزایش بقای پاتوژن:** ممکن است به بقای باکتری‌هایی مانند کلامیدیا در داخل سلول‌های ایمنی کمک کرده و باعث التهاب مزمن شود.

سوال ۳

سوال: در مورد یووئیت در اسپوندیلیت انکیلوزان AS کدام جمله صحیح است؟

(۱) یووئیت در AS بیشتر بصورت خلفی و دو طرفه است.

(۲) یووئیت جز تظاهرات نادر خارج مفصلی AS میباشد.

(۳) یووئیت میتواند قبل از شروع علائم مفصلی ایجاد شود.

(۴) بیشتر در افراد با HLA B27 منفی ایجاد می شود.

پاسخ صحیح: گزینه ۳

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ۳ (صحیح):** تظاهرات خارج مفصلی مانند یووئیت می تواند علامت اولیه بیماری در برخی بیماران باشد و حتی قبل از شروع دردهای مفصلی بروز کند و این بیماران ممکن است ابتدا به چشم پزشکی مراجعه کنند.
- **گزینه ۱ (غلط):** یووئیت تیپیک در axSpA به صورت **حاد، قدامی، یک طرفه و اپیزودیک** است. یووئیت خلفی و دوطرفه مشخصه این بیماری نیست.
- **گزینه ۲ (غلط):** یووئیت **شایع ترین** تظاهر خارج اسکلتی-عضلانی است و در حدود ۴۰٪ بیماران axSpA دیده می شود.
- **گزینه ۴ (غلط):** اگرچه در فایل به صراحت ذکر نشده، اما ارتباط قوی بین AS و HLA-B27 و همچنین شیوع بالای یووئیت در این بیماران، این گزینه را بسیار نامحتمل می کند. در واقع، یووئیت با HLA-B27 ارتباط قوی دارد.

توضیح کامل و نکته ای (درسنامه: یووئیت در اسپوندیلو آرتريت محوری):

- **شیوع:** یووئیت شایع ترین تظاهر خارج مفصلی در axSpA است و حدود ۴۰٪ بیماران را در طول دوره بیماری درگیر می کند.
- **مشخصات بالینی:** الگوی کلاسیک یووئیت در این بیماران به صورت زیر است:
 - **حاد (Acute):** شروع ناگهانی دارد.
 - **قدامی (Anterior):** قسمت جلویی چشم (عنبیه و جسم مژگانی) را درگیر می کند.
 - **یک طرفه (Unilateral):** معمولاً یک چشم را درگیر می کند، هرچند در حملات بعدی ممکن است چشم دیگر مبتلا شود.
 - **اپیزودیک (Episodic):** به صورت حملات تکرارشونده رخ می دهد.
- **علائم:** بیمار با ناراحتی چشم که به سرعت به قرمزی، درد، ترس از نور (فتوفوبی) و تنگی مردمک (میوزیس) تبدیل می شود، مراجعه می کند.
- **اهمیت تشخیصی:** یووئیت می تواند اولین علامت بیماری باشد و بیمار را قبل از بروز علائم اسکلتی به سمت پزشک بکشاند. وجود سابقه یووئیت یکی از ویژگی های مهم در الگوریتم تشخیصی SpA است.

سوال ۴

سوال: کدامیک از موارد زیر جز تظاهرات رادیوگرافیک اسپوندیلیت انکیلوزان نمی باشد؟

(۱) مربعی شدن مهره ها

۲) درخشان شدن گوشه قدامی مهره

۳) ایجاد سین دسموفیت

۴) نمای موم روان (Flowing wax) در قسمت قدامی جسم مهره

پاسخ صحیح: گزینه ۴

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ۴ (صحیح):** نمای "موم روان" (Flowing flowing osteophytes) مشخصه بیماری **DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis)** است که یک بیماری دژنراتیو بوده و در تشخیص افتراقی AS قرار می‌گیرد. این نما گاهی با "ستون فقرات بامبو" در AS اشتباه گرفته می‌شود.
- **گزینه‌های ۱، ۲ و ۳ (غلط):** این موارد همگی از یافته‌های رادیوگرافیک مشخصه axSpA در ستون فقرات هستند. "درخشان شدن گوشه قدامی مهره" (shiny corner sign or Romanus lesion) و "مربعی شدن مهره" (squaring) ناشی از اروژن در محل اتصال رباط‌ها به گوشه مهره‌ها است. "ایجاد سین‌دسموفیت" (syndesmophyte formation) که ناشی از استخوانی شدن لایه‌های خارجی دیسک بین مهره‌ای است، در مراحل بعدی بیماری دیده می‌شود.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: یافته‌های رادیوگرافیک در axSpA و تشخیص افتراقی آن):

- **یافته‌های رادیوگرافی ستون فقرات در axSpA:**
 - **تغییرات اولیه:**
 - **ضایعه رومانوس (Romanus lesion) یا علامت گوشه براق (Shiny corner sign):** اروژن و اسکروز واکنشی در گوشه‌های قدامی و خلفی جسم مهره.
 - **مربعی شدن مهره‌ها (Squaring of the vertebral body):** به دلیل اروژن در قسمت میانی قدامی مهره، حالت مقعر طبیعی آن از بین رفته و مهره صاف و مربعی به نظر می‌رسد.
 - **تغییرات پیشرفته:**
 - **سندسموفیت (Syndesmophyte):** استخوانی شدن لایه خارجی دیسک بین‌مهره‌ای که به صورت پل‌های استخوانی **عمودی و ظریف** بین مهره‌ها دیده می‌شود. این یافته با استئوفیت‌های افقی در آرتروز متفاوت است.
 - **ستون فقرات بامبو (Bamboo spine):** در مراحل بسیار پیشرفته، جوش خوردن کامل ستون فقرات به وسیله سندسموفیت‌ها این نما را ایجاد می‌کند.
- **تشخیص افتراقی رادیوگرافیک:**
 - **DISH (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis):** یک بیماری دژنراتیو و غیرالتهابی که در مردان مسن، چاق و دیابتی شایع‌تر است. مشخصه آن استخوانی شدن رباط طولی قدامی در حداقل **۴ مهره متوالی** و ایجاد استئوفیت‌های **حجیم و روان (flowing osteophytes)** است. نکته کلیدی در افتراق آن با AS، **نرمال بودن مفاصل ساکروایلیاک** در DISH است.

سوال ۵

سوال: خانم 45 ساله ای به علت درد و تورم زانوها مراجعه کرده در معاینه التهاب در مفاصل DIP هر دو دست و برخی از PIPها و ضایعات اریتماتوی پوسته ریزی دهنده در سطوح اکستانسور دیده میشود و در برخی از ناخنها هیپرکراتوز و فرورفتگیهایی مشاهده میگردد. در آزمایشات RF و Anti CCP منفی هستند. با توجه به این اطلاعات بیمار از کرایتریای CASPAR چند امتیاز می گیرد؟

(۱) ۲ امتیاز (۲) ۳ امتیاز (۳) ۴ امتیاز (۴) ۵ امتیاز

پاسخ صحیح: گزینه ۳ (۴ امتیاز) توضیح: در برخی فایلها پاسخ ۵ امتیاز ذکر شده که با فرض داشتن سابقه خانوادگی یا داکتیلیت صحیح است، اما با اطلاعات صورت سوال، ۴ امتیاز صحیحتر است.

پاسخ تشریحی: برای استفاده از معیارهای CASPAR، بیمار ابتدا باید **آرتريت التهابی** داشته باشد که در این بیمار (التهاب مفاصل دست و زانو) وجود دارد. سپس امتیازات به صورت زیر محاسبه می شود:

1. **پسوریازیس پوستی فعلی:** بیمار ضایعات پوسته ریزی دهنده در سطوح اکستانسور دارد. این معیار **۲ امتیاز** دارد.
2. **تغییرات ناخن پسوریاتیک:** بیمار هیپرکراتوز و فرورفتگی (pitting) در ناخنها دارد. این معیار **۱ امتیاز** دارد.
3. **منفی بودن فاکتور روماتوئید (RF):** در صورت سوال ذکر شده که RF منفی است. این معیار **۱ امتیاز** دارد.
4. **داکتیلیت:** در صورت سوال اشاره ای به داکتیلیت (انگشت سوسپسی) نشده است (امتیاز: ۰).
5. **شواهد رادیوگرافیک:** اطلاعاتی از رادیوگرافی ارائه نشده است (امتیاز: ۰).

مجموع امتیازات: $2 + 1 + 1 = 4$ امتیاز. برای تشخیص PSA بر اساس این معیارها، کسب حداقل **۳ امتیاز** لازم است. بنابراین، این بیمار معیارهای طبقه بندی PSA را دارد.

توضیح کامل و نکته ای (درسنامه: معیارهای تشخیصی CASPAR برای آرتريت پسوریاتیک): معیارهای CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis) حساسیت (۹۱.۴٪) و ویژگی (۹۸.۷٪) بالایی برای تشخیص PSA دارند.

- **شرط لازم:** وجود بیماری مفصلی التهابی (در مفاصل، ستون فقرات یا انترزیس).
- **سیستم امتیاز بندی (کسب حداقل ۳ امتیاز از ۵ دسته زیر):**
 - **پسوریازیس:**
 - **پسوریازیس فعلی** (توسط پزشک تأیید شده) = **۲ امتیاز**.
 - **سابقه شخصی** پسوریازیس = **۱ امتیاز**.
 - **سابقه خانوادگی** پسوریازیس (بستگان درجه ۱ یا ۲) = **۱ امتیاز**.
 - **دستروفي ناخن پسوریاتیک:** وجود علائمی مانند جدا شدن ناخن (onycholysis)، فرورفتگی (pitting) یا ضخیم شدن (۱) = hyperkeratosis **امتیاز**.
 - **منفی بودن تست فاکتور روماتوئید (۱) = (RF) امتیاز**.
 - **داکتیلیت:** تورم کل یک انگشت (انگشت سوسپسی)، چه در حال حاضر و چه در سابقه بیمار = **۱ امتیاز**.
 - **شواهد رادیوگرافیک:** وجود تشکیل استخوان جدید در کنار مفصل (juxta-articular new bone formation) در رادیوگرافی ساده دست یا پا = **۱ امتیاز**.

سوال ۶

سوال: خانم 30 ساله با پلی آرتريت مفاصل PIP، DIP، wrist به همراه Pitting ناخن ها و ضايعات پوستی قرمز رنگ همراه با پوسته ریزی روی آرنج ها و زانوها مراجعه کرده است. کدام عبارت زیر در مورد وی صحیح نمی باشد؟

۱) انکیلوز مفصلی به ندرت دیده میشود.

۲) توزیع اشعه مانند (Ray distribution) جز تظاهرات این بیماری است.

۳) Anti-CCP می تواند مثبت شود.

۴) درگیری مفصلی اغلب بعد از درگیری پوستی رخ می دهد.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ۱ (صحیح):** این عبارت **غلط** است. در آرتريت پسوریاتیک، تشکیل استخوان جدید می تواند منجر به **آنکیلوز (جوش خوردن) مفاصل** شود. این پدیده برخلاف آرتريت روماتوئید که عمدتاً تخریبی است، در PSA نادر نیست.
- **گزینه ۲ (غلط):** توزیع "پرتویی" یا "شعاعی" (Ray distribution) که به معنای درگیری تمام مفاصل یک انگشت (DIP, PIP, MCP) است، یکی از الگوهای مشخصه درگیری مفاصل در PSA است.
- **گزینه ۳ (غلط):** اگرچه RF و Anti-CCP معمولاً منفی هستند، اما در کمتر از ۱۰٪ بیماران PSA می توانند با تیترا پایین مثبت باشند.
- **گزینه ۴ (غلط):** در اکثر بیماران، تظاهرات پوستی پسوریازیس قبل از شروع آرتريت بروز می کند.

سوال ۷

سوال: آقای 28 ساله با درد و تورم و قرمزی زانوی چپ و تاندون آشیل راست که از یک هفته قبل شروع شده، مراجعه کرده است. وی سابقه عفونت تناسلی را تقریباً یک ماه قبل از شروع درگیری مفصل ذکر میکند. در معاینه زخم دهانی و آرتريت دارد... کدامیک از تشخیص های زیر بیشتر برای بیمار مطرح است؟

۱) آرتريت واکتیو (واکنشی) ۲) عفونت گنوکوکی منتشر ۳) اسپوندیلیت انکیلوزان ۴) (AS) لوپوس اریتماتوی سیستمیک

پاسخ صحیح: گزینه ۱

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ۱ (صحیح):** شرح حال بیمار کلاسیک آرتريت واکنشی است. ویژگی های کلیدی عبارتند از:
 - **عفونت پیشین:** سابقه عفونت ادراری-تناسلی حدود ۱ ماه قبل.
 - **الگوی آرتريت:** الیگوآرتريت نامتقارن با درگیری اندام تحتانی (زانو).

- **انتزیت:** درد تاندون آشیل.
- **تظاهرات مخاطی:** زخم دهانی.
- **گزینه ۲ (غلط):** عفونت گنوکوکی معمولاً با ضایعات پوستی و زیکولوپوسچولار همراه است و کشت مایع مفصل می‌تواند مثبت باشد.
- **گزینه ۳ (غلط):** اسپوندیلیت آنکیلوزان یک بیماری مزمن با شروع تدریجی است و معمولاً با کمردرد التهابی شروع می‌شود، نه یک آرتریت حاد پس از عفونت.
- **گزینه ۴ (غلط):** لوپوس یک بیماری سیستمیک با تظاهرات متنوع‌تر (راش پروانه‌ای، حساسیت به نور، درگیری کلیوی و...) است و الگوی آرتریت آن معمولاً پلی‌آرتریت متقارن مفاصل کوچک است.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: آرتریت واکنشی):

- **تعریف:** آرتریت واکنشی (ReA) به ایجاد آرتریت به دنبال یک عفونت ادراری-تناسلی یا گوارشی گفته می‌شود که ارگان‌یسم عامل عفونت از مفصل کشت داده نمی‌شود.
- **عوامل محرک شایع:** کلامیدیا (از راه تناسلی) و سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و کمپیلوباکتر (از راه گوارشی).
- **فاصله زمانی:** یک ویژگی کلیدی، فاصله زمانی بین عفونت اولیه و شروع آرتریت است که معمولاً بین ۱ روز تا ۴ هفته متغیر است.
- **تظاهرات بالینی:**
 - **اسکلتی-عضلانی:** الگوی تیپیک آن **الیگوآرتریت نامتقارن** است که ترجیحاً اندام تحتانی را درگیر می‌کند. انتزیت، داکتیلیت و کمردرد التهابی نیز شایع هستند.
 - **مخاطی-پوستی:** یوئیت/کونژنکتیویت، زخم‌های دهانی، کراتودرما بلنوراژیکا (ضایعات پوستی در کف دست و پا) و بالانیت چرخشی (ضایعات روی آلت تناسلی) ممکن است دیده شوند.
- **ارتباط با HLA-B27:** ارتباط بسیار قوی دارد و ۵۰-۸۰٪ بیماران این ژن را دارند. وجود HLA-B27 با ریسک بالاتر مزمن شدن بیماری همراه است

سوال ۸

سوال: انتزیت از مشخصات کدام یک از انواع بیماری‌های مفصلی زیر است؟

الف - آرتریت روماتوئید ب - لوپوس ج - اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها د - واسکولیت‌ها

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ج (صحیح):** فایل درسنامه به وضوح بیان می‌کند که **انتزیت (التهاب در محل اتصال تاندون‌ها و رباط‌ها به استخوان)** یکی از تظاهرات اسکلتی-عضلانی کلیدی و مشخصه خانواده بیماری‌های اسپوندیلوآرتريت (SpA) است. انتزیت در هر دو نوع محوری (axSpA) و محیطی (pSpA) یک یافته شایع است.

- **گزینه‌های الف، ب، د (غلط):** درسنامه انتزیت را به عنوان ویژگی SpA معرفی می‌کند و آن را در تقابل با آرتریت روماتوئید (RA) قرار می‌دهد که الگوی درگیری متفاوتی دارد. در فایل ارائه شده، هیچ اشاره‌ای به انتزیت به عنوان مشخصه اصلی بیماری‌های لوپوس یا واسکولیت نشده است.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: انتزیت در SpA): انتزیت یک علامت بالینی بسیار مهم در تشخیص و درک بیماری‌های اسپوندیلوآرتریت است.

- **تعریف:** انتزیت به التهاب در "انتز" (enthesis) گفته می‌شود که محل اتصال تاندون‌ها، رباط‌ها و کپسول‌های مفصلی به استخوان است.
- **اهمیت پاتوفیزیولوژیک:** انتزها به عنوان بافت‌های هدف کلیدی برای التهاب در SpA در نظر گرفته می‌شوند. اعتقاد بر این است که **استرس مکانیکی** در این نواحی باعث آسیب‌های کوچک (microdamage) می‌شود. در افراد مستعد به SpA، پاسخ ایمنی و ترمیمی به این آسیب‌ها، اغراق‌آمیز و طولانی‌مدت است که منجر به التهاب مزمن و تشکیل استخوان جدید و پاتولوژیک می‌شود.
- **تظاهرات بالینی شایع:** انتزیت می‌تواند در نقاط مختلف بدن رخ دهد و باعث دردهای موضعی شود، از جمله:
 - **درد پاشنه:** به دلیل التهاب فاشیای کف پا (Plantar fasciitis) یا محل اتصال تاندون آشیل.
 - **درد دیواره قفسه سینه:** در محل اتصال عضلات بین دنده‌ای.
 - **درد لگن، آرنج و زانو:** در محل اتصال تاندون‌های مربوطه.
- **ارتباط تشخیصی:** وجود انتزیت یک سرخ بالینی قوی برای تشخیص SpA است و به افتراق آن از سایر بیماری‌های مفصلی مانند آرتریت روماتوئید کمک می‌کند.

سوال ۹

سوال: مرد ۳۷ ساله ای به علت پلی آرتریت التهابی مراجعه میکند. در معاینه بالینی داکتیلیت انگشت دوم و سوم دست راست، اونیکولیز و در رادیوگرافی ستون فقرات گردن سین دسموفیت ساکروایلئیت غیر قرینه دارد کدامیک از یافته‌های فوق در افتراق آرتریت پسوریاتیک از AS (اسپوندیلیت انکیلوزان) کمک کننده تر است؟

الف - داکتیلیت ب - ساکروایلئیت غیر قرینه ج - انیکولیز د - درگیری مهره‌های گردن در مراحل اولیه

پاسخ صحیح: گزینه‌های الف، ب و ج همگی کمک‌کننده هستند اما **ساکروایلئیت غیرقرینه و داکتیلیت** از ویژگی‌های بسیار متمایز کننده هستند. با توجه به گزینه‌ها، **داکتیلیت** یک علامت بسیار مشخص برای PSA است که در AS کلاسیک نادر است.

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (صحیح و کمک‌کننده):** داکتیلیت (انگشت سوسیسی) یک علامت بسیار مشخص برای آرتریت پسوریاتیک است، در حالی که در اسپوندیلیت آنکیلوزان (axSpA) یک تظاهر **غیرشایع** محسوب می‌شود.
- **گزینه ب (صحیح و کمک‌کننده):** درگیری محوری در PSA (که در این بیمار با وجود سندسوموفیت و ساکروایلئیت وجود دارد) اغلب **نامتقارن** است. در مقابل، ساکروایلئیت در AS کلاسیک معمولاً **متقارن** است. بنابراین این یافته نیز در افتراق کمک می‌کند.

- **گزینه ج (صحیح و کمک‌کننده):** اونیکولیز (جدا شدن ناخن از بستر) یکی از انواع دیستروفی ناخن پسوریاتیک است که به طور مستقیم با PSA مرتبط است و در AS دیده نمی‌شود.
- **گزینه د (کمتر کمک‌کننده):** هر دو بیماری می‌توانند ستون فقرات گردن را درگیر کنند و درگیری در مراحل اولیه نمی‌تواند به تنهایی وجه افتراق قطعی باشد.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: افتراق آرتریت پسوریاتیک (PsA) از اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS): هر دو بیماری جزو خانواده اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها هستند و می‌توانند هم درگیری محوری (ستون فقرات) و هم محیطی داشته باشند، اما تفاوت‌های کلیدی در الگوی تظاهرات آنها وجود دارد:

ویژگی	آرتریت پسوریاتیک (PsA)	اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS / r-axSpA)
داکتیلیت	شایع و مشخصه بیماری، نشانگر شدت بیماری است.	نادر و غیرشایع است.
درگیری ناخن	شایع (اونیکولیز، پیتینگ، هیپرکراتوز).	وجود ندارد.
الگوی ساکروایلئیت	اغلب نامتقارن است.	معمولاً متقارن است.
الگوی سندسوموفیت	اغلب حجیم، خشن و نامتقارن است.	معمولاً ظریف، مارژینال و متقارن است.
درگیری مفاصل محیطی	بسیار شایع و متنوع؛ مفاصل DIP به طور مشخص درگیر می‌شوند.	در ۳۰-۴۰٪ موارد دیده می‌شود و به ندرت مفاصل کوچک دست را درگیر می‌کند.
ارتباط با HLA-B27	در ۲۰٪ کل بیماران و ۵۰٪ بیماران با درگیری محوری مثبت است.	در ۸۵-۹۰٪ بیماران مثبت است.

سوال ۱۰

سوال: آقای مبتلا به بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) در مورد ابتلا فرزند پسرش به بیماری مشابه با شما مشاوره می‌کند. فرزند ایشان HLAB27 مثبت می‌باشد احتمال ابتلای وی به بیماری AS چند درصد است؟

الف - ۶۵٪ ب - ۱۰-۳۰٪ ج - ۹۰٪ د - ۶٪

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ب (صحیح):** فایل درسنامه به طور مشخص بیان می‌کند که علی‌رغم ارتباط ژنتیکی قوی، تنها بخش کوچکی از افراد HLA-B27 مثبت به بیماری مبتلا می‌شوند و **ریسک ابتلا به AS در بستگان درجه اول HLA-B27 مثبت یک بیمار مبتلا به AS، تنها ۲۰٪ است.** گزینه "۱۰-۳۰٪" این محدوده را به خوبی پوشش می‌دهد.
- **سایر گزینه‌ها (غلط):** ۹۰٪ شیوع HLA-B27 در خود بیماران است، نه ریسک انتقال به فرزندان. ۶٪ تقریباً شیوع HLA-B27 در جمعیت عمومی است. این اعداد نشان می‌دهند که HLA-B27 برای بروز بیماری لازم است اما کافی نیست و عوامل دیگری نیز نقش دارند.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: ژنتیک و مشاوره در AS): درک نقش HLA-B27 در مشاوره ژنتیک برای بیماران AS و خانواده‌هایشان بسیار مهم است.

- **ارتباط قوی اما ناقص:** AS قوی‌ترین ارتباط را با یک ژن خاص (HLA-B27) در بین بیماری‌های پیچیده انسانی دارد.
- **نفوذ ناکامل ژن:** داشتن ژن HLA-B27 به معنای ابتلای قطعی به بیماری نیست.
 - بیشتر افراد دارای این ژن هرگز به بیماری مبتلا نمی‌شوند.
 - همانطور که در سوال ذکر شد، خطر ابتلا برای فرزند HLA-B27 مثبت یک بیمار مبتلا، فقط ۲۰٪ است.
- **نقش عوامل دیگر:** این آمار به وضوح نشان می‌دهد که برای شروع بیماری، علاوه بر استعداد ژنتیکی، به **عوامل اضافی** (مانند عوامل محیطی، عفونت‌ها، میکروبیوم روده، استرس مکانیکی) نیاز است.
- **نتیجه برای مشاوره:** در مشاوره با بیمار باید تأکید کرد که اگرچه ریسک ابتلا در فرزندان نسبت به جمعیت عمومی بالاتر است، اما این ریسک همچنان پایین است و احتمال اینکه فرزندان سالم بماند بسیار بیشتر (حدود ۸۰٪) است. غربالگری روتین فرزندان بدون علامت توصیه نمی‌شود.

سوال ۱۱

سوال: در مورد آرتریت انتروپاتیک (مرتبط با IBD) کدام مورد غلط است؟

الف) ممکن است آرتریت محیطی قبل از بیماری روده ای تظاهر یابد.

ب) نوع الیگو آرتریت ارتباطی با فعالیت IBD ندارد.

ج) اروزیون و دفورمیتی مفصلی ناشایع است.

د) پترن درگیری مفصلی در UC (کولیت اولسرو) و CD (بیماری کرون) مشابه است.

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ب (صحیح - عبارت غلط است):** فایل درسنامه اشاره می‌کند که درگیری محیطی در IBD می‌تواند به صورت **فرم‌های حاد الیگوآرتریت باشد که همزمان با شعله‌ور شدن (relapses) بیماری IBD رخ می‌دهد.** این نشان می‌دهد که این نوع آرتریت با فعالیت بیماری روده‌ای ارتباط دارد.

- **گزینه الف (غلط - عبارت درست است):** درگیری محوری (axSpA) می‌تواند قبل از تشخیص IBD بروز کند. این امر برای درگیری محیطی نیز ممکن است رخ دهد.
- **گزینه ج (غلط - عبارت درست است):** اگرچه فرم‌های مزمن SpA در بیماران IBD در صورت عدم درمان مناسب می‌توانند باعث آسیب ساختاری قابل توجه شوند، اما فرم حاد و واکنشی که با فعالیت روده مرتبط است، معمولاً غیراروزیو و غیرتخریبی است. (این گزینه کمی مبهم است اما گزینه "ب" به طور واضح‌تری غلط است).
- **گزینه د (غلط - عبارت درست است):** هر دو بیماری کولیت اولسراتیو (UC) و بیماری کرون (CD) با اسپوندیلوآرتریت (هم محوری و هم محیطی) مرتبط هستند و الگوی درگیری مشابهی را نشان می‌دهند.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: آرتریت مرتبط با بیماری التهابی روده (IBD)): "محور روده-مفصل" یک مفهوم کلیدی در پاتوفیزیولوژی SpA است. 

- **ارتباط دوطرفه:**
 - آرتریت در بیماران مبتلا به IBD شایع است (تا ۱۰٪ r-axSpA و ۳۰-۱۰٪ pSpA).
 - از طرف دیگر، تا ۵۰٪ بیماران SpA بدون علامت گوارشی، در مطالعات آندوسکوپی شواهد التهاب میکروسکوپی روده دارند.
- **تظاهرات بالینی:**
 - **درگیری محوری (Axial):** از نظر بالینی مشابه axSpA ایدیوپاتیک است. نکته مهم این است که زمان بروز آن می‌تواند مستقل از بیماری روده باشد؛ یعنی ممکن است سال‌ها قبل یا بعد از تشخیص IBD ظاهر شود.
 - **درگیری محیطی (Peripheral):** دو الگوی اصلی دارد:
 1. **نوع ۱ (الیگوارتیکولار):** یک آرتریت حاد و غیرمتقارن که کمتر از ۵ مفصل بزرگ (عمدتاً در پاها) را درگیر می‌کند. این نوع به شدت با فعالیت بیماری روده‌ای مرتبط است و با شعله‌ور شدن IBD، آرتریت نیز عود می‌کند.
 2. **نوع ۲ (پلی‌آرتیکولار):** یک آرتریت متقارن که مفاصل کوچک دست را درگیر می‌کند و سیر آن مستقل از فعالیت بیماری روده‌ای است.
- **ملاحظات درمانی:**
 - درمان باید هر دو جنبه مفصلی و روده‌ای را پوشش دهد.
 - **مهارکننده‌های TNF** (آنتی‌بادی‌های مونوکلونال مانند اینفلیکسیمب و آدالیمومب) در هر دو مؤثرند.
 - **مهارکننده‌های IL-17** به دلیل تشدید علائم روده‌ای، منع مصرف دارند.
 - **NSAIDها** باید با احتیاط فراوان و برای مدت کوتاه استفاده شوند، زیرا می‌توانند باعث شعله‌ور شدن IBD شوند.

سوال ۱۲

سوال: در مورد آگزپال اسپوندیلو آرتروپاتی کدام درست نیست؟

الف) پاسخ درمانی به NSAID (ب) اولین تظاهرات در پاتولوژی ساکروایلئیت (ج) استئوپروز در مراحل انتهایی دیده میشود

- **گزینه ج (صحیح - عبارت نادرست است):** فایل درسنامه بیان می‌کند که **پوکی استخوان (استئوپروز) یک عارضه شایع در axSpA است** و می‌تواند در ۴۰٪ بیماران وجود داشته باشد. مهم‌تر اینکه، درسنامه آن را به مراحل انتهایی محدود نمی‌کند و می‌گوید: "علی‌رغم این تغییرات استخوان‌سازی (osteoproliferative) در اسکلت، استئوپروز یک عارضه شایع است". التهاب مزمن خود می‌تواند باعث تحلیل استخوان شود، بنابراین پوکی استخوان می‌تواند در مراحل مختلف بیماری، و نه فقط در مراحل انتهایی، رخ دهد.
- **گزینه الف (غلط - عبارت درست است):** پاسخ خوب به داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) یکی از ویژگی‌های کلیدی اسپوندیلوآرتрит است و در الگوریتم تشخیصی به عنوان یکی از معیارهای SpA ذکر شده است.
- **گزینه ب (غلط - عبارت درست است):** **ساکروایلایت (التهاب مفصل ساکروایلایک)** یکی از اصلی‌ترین تظاهرات اسکلتی-عضلانی SpA است و اساس طبقه‌بندی بیماری به دو نوع رادیوگرافیک و غیررادیوگرافیک بر پایه وجود یا عدم وجود ساکروایلایت قطعی در رادیوگرافی است. بنابراین، این یافته پاتولوژیک، محوری و اغلب اولیه است.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: پوکی استخوان در AxSpA): وجود همزمان استخوان‌سازی جدید (مانند سندسوفیت‌ها) و پوکی استخوان یکی از پارادوکس‌های جالب در بیماری axSpA است.

- **شیوع:** پوکی استخوان یک عارضه شایع است و تا ۴۰٪ از بیماران مبتلا به axSpA را درگیر می‌کند.
- **مکانیسم:** علت پوکی استخوان در این بیماران چندعاملی است:
 - **التهاب مزمن:** سیتوکین‌های التهابی (مانند TNF- α) می‌توانند مستقیماً سلول‌های استئوکلاست (که استخوان را تخریب می‌کنند) را فعال کرده و منجر به تحلیل استخوان شوند.
 - **کاهش تحرک:** در مراحل پیشرفته‌تر، جوش خوردن ستون فقرات و محدودیت حرکتی باعث کاهش فشار مکانیکی روی استخوان‌ها شده و طبق قانون ولف، این امر منجر به کاهش تراکم استخوان می‌شود.
 - **کمبود ویتامین D و کلسیم:** ممکن است به دلیل کاهش فعالیت و قرار گرفتن در معرض نور خورشید رخ دهد.
- **اهمیت بالینی:** وجود پوکی استخوان، خطر شکستگی‌های مهره‌ای را در این بیماران به شدت افزایش می‌دهد، به خصوص در ستون فقراتی که به دلیل بیماری، خشک و شکننده شده است. بنابراین، ارزیابی ریسک پوکی استخوان در تمام بیماران axSpA، و نه فقط در مراحل انتهایی، اهمیت دارد.

سوال ۱۳

سوال: اینترلوکین ۲۳ در کدام عارضه AS (اسپوندیلیت انکیلوزان) نقش ندارد؟

الف) آرتریت اگزپال (محوری) ب) آرتریت محیطی ج) پسوریازیس د) IBD (بیماری التهابی روده)

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (صحیح):** فایل درسنامه به صراحت بیان می‌کند که بین axSpA و IBD، علی‌رغم اشتراکات ژنتیکی، تفاوت اساسی در وابستگی به سیتوکین‌ها وجود دارد. در حالی که مهار IL-17A در axSpA مؤثر است، **مهار IL-23 هیچ سودی در axSpA (آرتريت محوری) ندارد.**

- **گزینه‌های ب، ج، د (غلط):** فایل درسنامه نقش IL-23 را در این عوارض تایید می‌کند:
 - **آرتريت محیطی (در زمینه PSA):** "در PSA، به نظر می‌رسد مهارکننده‌های IL-23 و IL-17 هر دو مؤثر هستند."
 - **پسوریازیس و IBD:** "مهارکننده‌های IL-23 در IBD تأیید شده‌اند." تصویر صفحه ۱۰ نیز به وضوح نشان می‌دهد که داروهای Anti-IL-23 برای درمان PSA، IBD، Psoriasis (پسوریازیس) استفاده می‌شوند.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: محور IL-23/IL-17 در دامنه‌های مختلف SpA): محور سیتوکینی IL-23/IL-17 یکی از مسیرهای اصلی در پاتوفیزیولوژی بیماری‌های ایمنی‌محور است، اما اهمیت آن در زیرگروه‌های مختلف SpA متفاوت است که این امر پیامدهای درمانی مهمی دارد.

- **نقش کلی:** IL-23 توسط سلول‌های ارائه‌دهنده آنتی‌ژن تولید شده و باعث تمایز و فعال‌سازی سلول‌های T کمکی ۱۷ (Th17) می‌شود. این سلول‌ها سپس IL-17 را تولید می‌کنند که یک سیتوکین التهابی قوی است.

- **وابستگی متفاوت در دامنه‌های بیماری:**

- **اسپوندیلوآرتريت محوری (Axial SpA):** این بیماری به شدت به IL-17 وابسته است، اما به نظر می‌رسد مسیر التهابی آن مستقل از IL-23 است. به همین دلیل داروهای مهارکننده IL-17 (مانند سکوکینومب) در این بیماری بسیار مؤثرند، اما مهارکننده‌های IL-23 (مانند اوستکینومب) اثری ندارند.
- **آرتريت پسوریاتیک (PsA) و پسوریازیس پوستی:** در این بیماری‌ها، **کل محور IL-23/IL-17** نقش دارد. بنابراین، هم مهارکننده‌های IL-23 و هم مهارکننده‌های IL-17 در درمان آنها مؤثر هستند.
- **بیماری التهابی روده (IBD):** این بیماری به IL-23 وابسته است، اما IL-17 در اینجا نقشی دوگانه و حتی محافظتی برای سد روده دارد. به همین دلیل، مهارکننده‌های IL-23 در درمان IBD تأیید شده‌اند، اما **مهارکننده‌های IL-17 در بیماران مبتلا به IBD فعال، منع مصرف دارند** زیرا می‌توانند بیماری را تشدید کنند.

سوال ۱۴

سوال: بیمار آقای جوان ۳۲ ساله با سابقه ی دردهای دو طرفه ی باتوک و کمردرد التهابی و انتزیت مراجعه کرده است. کدام درگیری خارج مفصلی زیر در ایشان بیشتر قابل انتظار می رود؟

الف) ILD (بیماری بینایی ریه) ب) IgA نفروپاتی ج) نارسایی آئورت د) IBD (بیماری التهابی روده)

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی: شرح حال بیمار (مرد جوان با کمردرد التهابی و انتزیت) به شدت مطرح‌کننده axSpA است. فایل درسنامه شیوع تظاهرات خارج مفصلی را به صورت زیر بیان می‌کند:

- **یوئیت:** شایع‌ترین تظاهر (۴۰٪).
- **IBD (بیماری التهابی روده):** در ۱۰٪ موارد به صورت بالینی واضح و در تا ۵۰٪ موارد به صورت التهاب تحت بالینی (subclinical) در مطالعات بافتی دیده می‌شود.
- **پسوریازیس:** در ۱۰٪ موارد.
- **نارسایی آئورت:** به عنوان یک **عارضه دیررس** ذکر شده و شیوع آن کمتر است.
- **IgA نفروپاتی و ILD:** به عنوان عوارض احتمالی ذکر شده‌اند اما شیوع آنها به اندازه موارد فوق نیست. با توجه به گزینه‌های موجود و شیوع ذکر شده، **IBD** (با در نظر گرفتن فرم تحت بالینی) شایع‌ترین و مورد انتظارترین عارضه در بین گزینه‌ها است.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: تظاهرات خارج اسکلتی-عضلانی در AxSpA): بیماری axSpA یک بیماری سیستمیک است و می‌تواند ارگان‌های مختلفی را فراتر از مفاصل و ستون فقرات درگیر کند. آگاهی از این تظاهرات برای تشخیص و مدیریت کامل بیمار ضروری است.

- **شایع‌ترین تظاهرات:**
 - **یوئیت قدامی حاد (Uveitis):** شایع‌ترین (۴۰٪)، با مشخصات حاد، یک‌طرفه و راجعه.
 - **بیماری التهابی روده (IBD):** ارتباط بسیار قوی دارد. ۱۰٪ بیماران به کرون یا کولیت اولسراتیو مبتلا می‌شوند و تا ۵۰٪ التهاب خاموش روده دارند.
 - **پسوریازیس (Psoriasis):** در حدود ۱۰٪ بیماران axSpA دیده می‌شود.
- **سایر تظاهرات:**
 - **قلبی:** اختلالات هدایتی (بلوک قلبی) می‌تواند در هر مرحله‌ای رخ دهد. نارسایی دریچه آئورت یک عارضه دیررس است.
 - **کلیوی:** نفروپاتی IgA (با تظاهر هماچوری میکروسکوپی) و آمیلوئیدوز کلیوی (یک عارضه بسیار دیررس در بیماری کنترل‌نشده) از عوارض کلیوی هستند.
 - **ریوی:** فیبروز قسمت‌های فوقانی ریه (apical fibrosis) و بیماری‌های ریوی تحدیدی (restrictive) به دلیل خشکی قفسه سینه در مراحل پیشرفته دیده می‌شوند.
 - **پوکی استخوان (Osteoporosis):** یک عارضه شایع (۴۰٪) که ریسک شکستگی را افزایش می‌دهد.

سوال ۱۵

سوال: در مورد Non radiographic SpA کدامیک صحیح نیست؟

الف) اکثر موارد در آینده دچار ساکروایلئیت رادیوگرافیک می‌شوند.

ب) شیوع آن در خانمها بیشتر است.

ج) میزان بروز HLAB27 در آن پایین تر است.

د) شواهد درگیری ساکروایلیاک در MRI وجود دارد.

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (صحیح - عبارت نادرست است):** فایل درسنامه بیان می‌کند که "نزدیک به ۵۰٪ از بیماران طی ۲۰ سال از مرحله غیر رادیوگرافیک به رادیوگرافیک پیشرفت می‌کنند". بنابراین، گفتن اینکه "اکثر موارد" پیشرفت می‌کنند، صحیح نیست. نیمی از بیماران ممکن است هرگز به مرحله رادیوگرافیک نرسند.
- **گزینه ب (غلط - عبارت نادرست است اما نه به اندازه گزینه الف):** درسنامه ذکر می‌کند که نسبت جنسیتی (مرد به زن) برای nr-axSpA برابر (۱:۱) است، در حالی که برای r-axSpA این نسبت ۲:۱ به نفع مردان است. پس شیوع آن در خانمها "بیشتر" نیست، بلکه برابر با مردان است. با این حال، نادرستی گزینه الف قطعی‌تر است.
- **گزینه ج (غلط - عبارت درست است):** شیوع HLA-B27 در r-axSpA حدود ۸۵-۹۰٪ و در nr-axSpA بین ۵۰-۹۰٪ گزارش شده است. این محدوده وسیع نشان می‌دهد که میزان بروز آن می‌تواند در گروه غیررادیوگرافیک پایین‌تر باشد.
- **گزینه د (غلط - عبارت درست است):** MRI نقش کلیدی در تشخیص nr-axSpA دارد. الگوریتم تشخیصی نشان می‌دهد که در صورت منفی بودن رادیوگرافی، مثبت شدن MRI برای ساکروایلیت می‌تواند تشخیص را تأیید کند. MRI می‌تواند التهاب فعال (استئیت) را سال‌ها قبل از بروز تغییرات ساختاری در رادیوگرافی نشان دهد.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: اسپوندیلو آرتريت محوری غیر رادیوگرافیک (nr-axSpA): nr-axSpA بخش مهمی از طیف بیماری axSpA را تشکیل می‌دهد که درک آن در سال‌های اخیر متحول شده است.

- **تعریف:** بیماران nr-axSpA تمام علائم بالینی axSpA (مانند کمردرد التهابی، انتزیت، یوئیت و...) را دارند، اما در رادیوگرافی ساده لگن، شواهد **قطعی** ساکروایلیت (بر اساس معیارهای اصلاح‌شده نیویورک) را نشان نمی‌دهند.
- **تشخیص:** تشخیص اغلب با ترکیبی از موارد زیر صورت می‌گیرد:
 - وجود ویژگی‌های بالینی SpA.
 - مثبت بودن HLA-B27.
 - **مثبت بودن MRI مفاصل ساکروایلیاک** که التهاب فعال (اِدم مغز استخوان) را نشان می‌دهد.
- **رابطه با r-axSpA:**
 - nr-axSpA و r-axSpA دو روی یک سکه و بخشی از یک طیف بیماری هستند، نه دو بیماری مجزا.
 - بار بیماری، کیفیت زندگی و شدت علائم در هر دو گروه مشابه است.
 - تنها حدود **نیمی** از بیماران nr-axSpA در طول زمان (مثلاً ۲۰ سال) به مرحله رادیوگرافیک (r-axSpA) پیشرفت می‌کنند.
- **ویژگی‌های اپیدمیولوژیک:**
 - نسبت جنسیتی در nr-axSpA برابر (۱:۱) است که این امر به تشخیص دیرنگام در زنان (که کمردردشان اغلب به فیبرومیالژیا نسبت داده می‌شود) کمک کرده است.

سوال: آقای ۲۴ ساله با سابقه ی کمردرد التهابی از ۹ ماه قبل مراجعه کرده است. در معاینه تندرست دور قفسه سینه، مهره های کمر و ساکروایلیاک و پشت پای راست وجود دارد. زانوی چپ متورم و گرم است و حرکات کمر محدود شده است. برای تشخیص بیماری در ایشان کدام گزینه را انتخاب می کنید؟

الف) رادیوگرافی قفسه سینه ب) رادیو گرافی مهره های کمر ج) رادیوگرافی لگن د) رادیوگرافی لترال پای راست

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ج (صحیح):** شرح حال بیمار (مرد جوان با کمردرد التهابی، درد قفسه سینه و لگن (انتزیت و ساکروایلیت)، آرتریت محیطی (زانو) و محدودیت حرکتی) به شدت مطرح کننده اسپوندیلوآرتریت محوری (axSpA) است. بر اساس الگوریتم تشخیصی ارائه شده در درسنامه و توضیحات متنی، اولین و مهم ترین اقدام تصویربرداری برای طبقه بندی بیمار، **رادیوگرافی لگن** به منظور ارزیابی مفاصل ساکروایلیاک (SIJ) برای وجود ساکروایلیت قطعی است. درسنامه تاکید می کند که "یک نمای AP یا فرگوسن از لگن برای تصویربرداری از مفاصل ساکروایلیاک کافی است".
 - **گزینه الف (غلط):** رادیوگرافی قفسه سینه برای ارزیابی اولیه تشخیصی axSpA کاربردی ندارد، مگر برای رد کردن سایر علل درد قفسه سینه.
 - **گزینه ب (غلط):** اگرچه رادیوگرافی مهره های کمر می تواند تغییرات بعدی بیماری مانند سندسُموفیت ها را نشان دهد، اما برای تشخیص و طبقه بندی اولیه، ارزیابی مفاصل ساکروایلیاک در اولویت است.
 - **گزینه د (غلط):** رادیوگرافی پا برای ارزیابی کمردرد و علائم محوری بیمار بی ارتباط است.
- توضیح کامل و نکته ای (درسنامه: نقش تصویربرداری در تشخیص AxSpA):** تصویربرداری نقش محوری در تشخیص و طبقه بندی اسپوندیلوآرتریت محوری دارد.

• رادیوگرافی ساده (X-ray):

- **رادیوگرافی لگن (Pelvis X-ray):** این اولین و اساسی ترین ابزار است. هدف اصلی آن بررسی مفاصل ساکروایلیاک (SIJ) برای یافتن علائم ساکروایلیت است که شامل اسکروز (سفید شدن استخوان)، اروژن (خوردگی)، پهن یا تنگ شدن فضای مفصلی و در نهایت فیوژن (جوش خوردن) مفصل می باشد.
- **معیار تشخیصی:** وجود "ساکروایلیت قطعی" (طبق معیارهای اصلاح شده نیویورک) در رادیوگرافی، تشخیص را به سمت **axSpA رادیوگرافیک (r-axSpA) یا همان اسپوندیلیت آنکیلوزان** سوق می دهد.
- **رادیوگرافی ستون فقرات:** برای ارزیابی تغییرات بعدی بیماری مانند ضایعه رومانوس، مربعی شدن مهره ها و سندسُموفیت ها استفاده می شود اما ابزار خط اول تشخیص نیست.

• MRI:

- در بیمارانی که علائم بالینی قوی دارند اما رادیوگرافی آنها طبیعی است، MRI مفاصل ساکروایلیاک ابزار انتخابی است.
- MRI می تواند **التهاب فعال (ایم مغز استخوان یا استئیت)** را که سال ها قبل از تغییرات ساختاری در رادیوگرافی رخ می دهد، نشان دهد و به تشخیص **axSpA غیررادیوگرافیک (nr-axSpA)** کمک کند.

سوال ۱۷

سوال: کدام سایتوکاین زیر در مراحل پیشرفته اسپوندیلیت انکیلوزان (AS) افزایش می یابد؟ الف) TNF- α ب) IL-17 ج) IL-23 د) TGF- β

پاسخ صحیح: بر اساس فایل درسنامه، گزینه های الف و ب هر دو نقش کلیدی در تمام مراحل بیماری دارند، اما IL-17 ارتباط مستقیم تری با پاتولوژی مراحل پیشرفته (استخوان سازی) دارد.

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف و ب (صحیح بر اساس درسنامه):** فایل درسنامه به وضوح بیان می کند که TNF و IL-17 **سیتوکین های شاخص (signature cytokines) در ایمونوپاتولوژی axSpA هستند.**

○ **TNF- α :** به عنوان یک "مسیر اجرایی مشترک" توصیف شده که در فرآیند التهاب نقش دارد و باعث تخریب استخوان (bone loss) می شود.

○ **IL-17:** به طور خاص در فرآیند **تشکیل استخوان جدید و پاتولوژیک** نقش دارد. درسنامه ذکر می کند که این سیتوکین (به همراه IL-22 و PGE) باعث تمایز استئوبلاست ها شده و در نهایت به ایجاد سندسوموفیت و جوش خوردن مفاصل (آنکیلوز) منجر می شود که مشخصه اصلی **مراحل پیشرفته** بیماری است. بنابراین، IL-17 ارتباط مفهومی قوی تری با "مراحل پیشرفته" دارد.

- **گزینه ج (غلط):** درسنامه صراحتاً بیان می کند که مهار IL-23 در درمان axSpA سودی ندارد و این بیماری برخلاف IBD و PsA، وابستگی به IL-23 ندارد.

- **گزینه د (غلط):** در کل فایل درسنامه ارائه شده، هیچ اشاره ای به سیتوکین TGF- β نشده است. بنابراین بر اساس منبع موجود، این گزینه قابل دفاع نیست.

توضیح کامل و نکته ای (درسنامه: نقش سیتوکین ها در پیشرفت AS): پاتوفیزیولوژی AS یک فرآیند پیچیده است که در آن التهاب مزمن منجر به آسیب ساختاری می شود. دو سیتوکین اصلی در این فرآیند نقش دارند:

- **TNF- α (فاکتور نکروز تومور آلفا):**

○ یک سیتوکین التهابی بسیار قوی است که توسط ماکروفاژها، نوتروفیل ها و سلول های T فعال تولید می شود.
○ باعث فعال شدن سلول های ایمنی، فیبروبلاست ها و استئوکلاست ها می شود.
○ نقش اصلی آن در **التهاب مزمن و تخریب استخوان (اروزیون)** است. مهارکننده های TNF به طور گسترده در درمان تمام جنبه های SpA استفاده می شوند.

- **IL-17 (اینترلوکین ۱۷):**

○ این سیتوکین نیز یک محرک قوی التهاب است.
○ ویژگی منحصر به فرد آن در SpA، نقشش در **تحریک استخوان سازی جدید و پاتولوژیک** است.
○ **مکانیسم در مراحل پیشرفته:** التهاب مزمن در انتزها (محل اتصال رباط به استخوان)، به جای ترمیم طبیعی، منجر به تمایز سلول های استخوان ساز (استئوبلاست) می شود. IL-17 یکی از محرک های اصلی این فرآیند است که در نهایت به تشکیل پل های استخوانی (سندسوموفیت) و جوش خوردن ستون فقرات (آنکیلوز یا ستون

فقرات بامبو) می‌انجامد. بنابراین، هرچند هر دو سیتوکین در تمام مراحل بیماری فعال هستند، IL-17 به طور خاص با ویژگی‌های آسیب ساختاری مراحل پیشرفته AS مرتبط است.

سوال ۱۸

سوال: آقای مبتلا به بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان (AS) در مورد ابتلا فرزند پسرش به بیماری مشابه با شما مشاوره می‌کند. فرزند ایشان HLAB27 مثبت می‌باشد. بر اساس معیارهای (ASAS) (Assessment of spondyloarthritis international society) در صورت وجود کدامیک از علائم زیر ایشان در گروه اسپوندیلو آرتروپاتی‌ها طبقه‌بندی می‌شود؟

الف) درد لگن ب) کنژنکتیویت ج) ESR بالا د) CRP بالا

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی: این سوال به دنبال یکی از معیارهای طبقه‌بندی ASAS است. بیمار از قبل چند ویژگی SpA را دارد (سابقه خانوادگی مثبت، HLA-B27 مثبت). سوال می‌پرسد کدام یک از علائم زیر می‌تواند به طبقه‌بندی او کمک کند. بر اساس الگوریتم تشخیصی صفحه ۳۶، لیستی از "ویژگی‌های SpA" ارائه شده است:

- کمردرد التهابی (IBP)
- آرتريت التهابی
- یووئیت
- داکتیلیت
- انتزیت
- پسوریازیس
- IBD
- سابقه خانوادگی
- پاسخ خوب به NSAIDs
- CRP بالا

با بررسی گزینه‌ها:

- **گزینه د (صحیح):** CRP بالا به صراحت در لیست ویژگی‌های SpA در الگوریتم تشخیصی ذکر شده است.
- **گزینه الف (می‌تواند صحیح باشد اما کمتر دقیق است):** "درد لگن" اگر ناشی از آرتريت التهابی مفصل ران (هیپ) باشد، جزو معیار "آرتريت التهابی" محسوب می‌شود. اما این یک تفسیر است، در حالی که "CRP بالا" به طور مستقیم ذکر شده است.
- **گزینه ب (غلط):** در برنامه به یووئیت (Uveitis) به عنوان تظاهر چشمی اشاره می‌کند، نه کنژنکتیویت.
- **گزینه ج (غلط):** اگرچه ESR نیز یک مارکر التهابی است، اما در لیست الگوریتم تشخیصی ASAS که در در برنامه آمده، به طور مشخص به CRP بالا اشاره شده است و ESR ذکر نشده است.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: معیارهای طبقه‌بندی ASAS برای AxSpA): برای تشخیص و طبقه‌بندی اسپوندیلوآرتریت محوری (axSpA) در بیمارانی که کمردرد مزمن با شروع قبل از ۴۵ سالگی دارند، از معیارهای ASAS استفاده می‌شود. این معیارها دو بازو دارند:

• **بازوی تصویربرداری (Imaging Arm):**

- **شرط لازم:** وجود ساکروایلایت در تصویربرداری (یا در رادیوگرافی ساده یا در MRI).
- **به علاوه:** حداقل یک ویژگی دیگر از لیست SpA.

• **بازوی بالینی (Clinical Arm):**

- **شرط لازم:** مثبت بودن تست HLA-B27.
- **به علاوه:** حداقل دو ویژگی دیگر از لیست SpA.

"ویژگی‌های SpA" که در هر دو بازو استفاده می‌شوند عبارتند از:

- کمردرد التهابی
- آرتریت (التهاب مفاصل محیطی)
- انتزیت (درد پاشنه یا سایر محل‌ها)
- یووئیت قدامی
- داکتیلیت (انگشت سوسپسی)
- پسوریازیس
- بیماری کرون یا کولیت اولسراتیو (IBD)
- پاسخ خوب به NSAIDs
- سابقه خانوادگی SpA
- **CRP بالا**

سوال ۱۹

سوال: آقای ۲۵ ساله با درد و تورم و قرمزی مچ پای راست و زانوی راست از ده روز قبل مراجعه کرده است. وی سه هفته قبل سابقه ای از گاستروآرتریت میدهد که پس از پنج روز بهبود یافته است. کدام جمله در مورد ایشان درست نیست؟

(الف) ممکن است زخم دهانی بدون درد داشته باشند.

(ب) کشت مایع مفصل ارگانیزم روده ای را نشان می دهد.

(ج) HLA B27 می تواند مثبت باشد.

(د) بیماری ایشان طی ۳ ماه معمولاً بهبود می یابد.

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ب (صحیح - عبارت نادرست است):** تعریف آرتریت واکنشی (ReA) در فایل درسنامه به صراحت بیان می‌کند که این بیماری به دنبال یک عفونت زمینه‌ای رخ می‌دهد، اما میکروارگانیسم‌های محرک "به طور طبیعی از مفاصل درگیر قابل کشت نیستند". بنابراین، انتظار نداریم که کشت مایع مفصل، باکتری روده‌ای را نشان دهد.
 - **گزینه الف (غلط - عبارت درست است):** ضایعات مخاطی-پوستی مانند زخم‌های دهانی (oral ulcers) می‌توانند بخشی از طیف بالینی آرتریت واکنشی باشند.
 - **گزینه ج (غلط - عبارت درست است):** آرتریت واکنشی ارتباط بسیار قوی با ژن HLA-B27 دارد و تا ۵۰-۸۰٪ بیماران این ژن را دارند.
 - **گزینه د (غلط - عبارت درست است):** درسنامه اشاره می‌کند که آرتریت واکنشی در بخش بزرگی از بیماران به عنوان یک بیماری خودمحدودشونده (self-limiting) و بهبود یابنده در نظر گرفته می‌شود. اگرچه می‌تواند مزمن شود، اما بهبود در عرض چند ماه یک دوره شایع است.
- توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: تشخیص و ویژگی‌های آرتریت واکنشی):** آرتریت واکنشی یک عضو مهم از خانواده اسپوندیلوآرتریت‌های محیطی است.
- **تعریف:** آرتریتی که به دنبال یک عفونت در دستگاه گوارش (GI) یا ادراری-تناسلی (GU) ایجاد می‌شود و خود مفصل استریل است (عامل عفونی در آن یافت نمی‌شود).
 - **عوامل محرک:**
 - **گوارشی:** سالمونلا، شیگلا، یرسینیا، کمپیلوباکتر.
 - **ادراری-تناسلی:** کلامیدیا تراکوماتیس.
 - **ویژگی‌های بالینی کلیدی:**
 - **فاصله زمانی:** یک تأخیر مشخص (معمولاً ۱ تا ۴ هفته) بین عفونت اولیه و شروع علائم مفصلی وجود دارد.
 - **الگوی مفصلی:** الیگوآرتریت (درگیری کمتر از ۵ مفصل) نامتقارن که عمدتاً مفاصل بزرگ اندام تحتانی را درگیر می‌کند.
 - **سایر علائم اسکلتی:** انتزیت (التهاب محل اتصال تاندون)، داکتیلیت (انگشت سوسپسی) و کمردرد التهابی نیز شایع هستند.
 - **علائم خارج مفصلی:** یووئیت/کونژکتیویت، زخم‌های دهانی، و ضایعات پوستی خاص (کراتودرما پلنوراژیکا) ممکن است دیده شوند.
 - **نقش HLA-B27:** ارتباط قوی با این ژن وجود دارد (تا ۸۰٪ موارد) و حضور آن با ریسک بالاتری برای مزمن شدن بیماری همراه است.

سوال ۲۰

سوال: در کدام بیمار زیر احتمال مثبت شدن HLA B27 کمتر است؟

- الف) خانم ۳۵ ساله با کمر درد التهابی و درد پاشنه پا و سابقه پسوریازیس
- ب) آقای ۲۲ ساله با سابقه کمر درد التهابی و ساکروایلئیت دو طرفه در رادیوگرافی

ج) آقای 45 ساله با سابقه بیماری کرون و پلی آرتریت

د) خانم 27 ساله با سابقه آرتریت زانوهای یک هفته پس از یورتريت

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی: بیایید احتمال مثبت شدن HLA-B27 را در هر گزینه بر اساس درسنامه بررسی کنیم:

- **گزینه ب:** این بیمار تعریف کلاسیک **اسپوندیلیت آنکیلوزان (r-axSpA)** را دارد. درسنامه شیوع HLA-B27 در این گروه را ۸۵-۹۰٪ ذکر می‌کند که بالاترین احتمال در بین گزینه‌ها است.
- **گزینه د:** این بیمار شرح حال **آرتریت واکنشی (ReA)** را دارد. شیوع HLA-B27 در این گروه ۵۰-۸۰٪ است.
- **گزینه الف:** این بیمار مبتلا به **آرتریت پسوریاتیک (PsA)** با **درگیری محوری** است (کمردرد التهابی دارد). درسنامه شیوع HLA-B27 در بیماران PsA با درگیری محوری را ۵۰٪ ذکر می‌کند.
- **گزینه ج:** این بیمار مبتلا به **آرتریت مرتبط با IBD از نوع محیطی (پلی‌آرتریت)** است. درسنامه بیان می‌کند که HLA-B27 قوی‌ترین ارتباط را با **درگیری محوری (axial)** در تمام انواع SpA دارد. اگرچه آرتریت مرتبط با IBD جزو این خانواده است، اما درگیری صرفاً محیطی معمولاً ارتباط ضعیف‌تری با HLA-B27 نسبت به فرم‌های محوری یا آرتریت واکنشی دارد. شیوع کلی HLA-B27 در آرتریت پسوریاتیک (که شامل فرم‌های محیطی هم می‌شود) ۲۰٪ است. می‌توان انتظار داشت که درگیری صرفاً محیطی در IBD نیز شیوع پایین‌تری نسبت به گزینه‌های دیگر داشته باشد. بنابراین، این گزینه **کمترین احتمال** را دارد.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: شیوع HLA-B27 در زیرگروه‌های مختلف SpA): ژن HLA-B27 در تمام خانواده اسپوندیلوآرتریت‌ها یک عامل خطر مهم است، اما فراوانی آن در زیرگروه‌های مختلف متفاوت است و به طور کلی ارتباط آن با درگیری محوری (ستون فقرات و ساکروایلیاک) بسیار قوی‌تر است.

- **اسپوندیلیت آنکیلوزان (r-axSpA):** قوی‌ترین ارتباط با ۸۵-۹۰٪ شیوع.
- **axSpA غیررادیوگرافیک (nr-axSpA):** شیوع ۵۰-۹۰٪.
- **آرتریت واکنشی (ReA):** ارتباط قوی با شیوع ۵۰-۸۰٪.
- **آرتریت پسوریاتیک (PsA):**
 - در کل بیماران ۲۰٪ PSA.
 - در بیماران PsA با درگیری محوری: ۵۰٪.
- **آرتریت مرتبط با IBD:** درسنامه عدد دقیقی ارائه نمی‌دهد، اما منطق مشابهی حاکم است: بیمارانی که درگیری محوری دارند، احتمال بالاتری برای مثبت بودن HLA-B27 دارند نسبت به کسانی که فقط آرتریت محیطی دارند.

سوال ۲۱

سوال: خانم 38 ساله ای به علت درد باسن راست و مفاصل متعدد دست مراجعه کرده است. در معاینه التهاب در مفاصل DIP هر دو دست و برخی از PIPها، کوتاه شدن انگشت سوم هر دو دست، سوسپسی شدن انگشت دوم راست وجود دارد وضایعات

اریتماتوی پوسته ریزی دهنده در سطوح اکستانسور دیده میشود و در برخی از ناخنها هیپرکراتوز و فرورفتگی هایی مشاهده می گردد. کدام درگیری زیر در ایشان مشخصه (Characteristic) است؟

الف) داکتیلیت ب) کوتاه شدن انگشت ج) درگیری DIP د) درگیری PIP

پاسخ صحیح: این سوال کمی مبهم است زیرا گزینه های الف، ب، و ج همگی از ویژگی های بسیار مشخصه آرتریت پسوریاتیک (PSA) هستند. با این حال، "کوتاه شدن انگشت" نماینده شدیدترین و مخرب ترین فرم بیماری یعنی **آرتریت موتیلان** است.

پاسخ تشریحی: این بیمار دارای مجموعه کاملی از علائم کلاسیک آرتریت پسوریاتیک است. بیایید هر گزینه را بررسی کنیم:

- **گزینه الف (داکتیلیت):** "انگشت سوسیسی" یکی از علائم کلیدی SpA و به ویژه PSA است. درسنامه آن را به عنوان یک **نشانه شدة بیماری** معرفی می کند.
- **گزینه ج (درگیری DIP):** درگیری مفاصل دیستال اینترفالانژیال (نزدیک به نوک انگشتان) به عنوان یک یافته "**تیبیکال برای PSA**" توصیف شده است، به خصوص زمانی که با تغییرات ناخن همراه باشد. این یافته به افتراق PSA از آرتریت روماتوئید کمک زیادی می کند.
- **گزینه ب (کوتاه شدن انگشت):** این علامت نشان دهنده **آرتریت موتیلان (Arthritis Mutilans)** است که در آن تخریب شدید استخوان (استئولیز) رخ می دهد. درسنامه این حالت را به عنوان "**تظاهر نهایی یک فرآیند آرتریت شدید**" توصیف می کند. این مخرب ترین و تغییر شکل دهنده ترین ویژگی PSA است.
- **گزینه د (درگیری PIP):** درگیری مفاصل پروگزیمال اینترفالانژیال (مفاصل میانی انگشتان) در PSA شایع است، اما در بیماری های دیگر مانند آرتریت روماتوئید نیز بسیار شایع است و به اندازه سه گزینه دیگر برای PSA "مشخصه" محسوب نمی شود.

با توجه به اینکه تمام سه گزینه اول مشخصه هستند، انتخاب "بهترین" گزینه به تفسیر کلمه "مشخصه" بستگی دارد. درگیری DIP و داکتیلیت شایع تر و برای تشخیص کاربردی تر هستند، اما آرتریت موتیلان (کوتاه شدن انگشت) منحصر به فردترین و شدیدترین تظاهر این بیماری است.

سوال ۲۲

سوال: کدام اختلال زیر جز تظاهرات آرتریت پسوریاتیک نمی باشد؟ الف) نفرس ب) یووئیت ج) نارسایی آئورت د) کلاینگ

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (صحیح - جزو تظاهرات نیست):** **نفرس (Gout)** یک بیماری کاملاً مجزا است که به دلیل رسوب کریستال های اورات سدیم ایجاد می شود و جزو تظاهرات آرتریت پسوریاتیک محسوب نمی شود.
- **گزینه ب (غلط - جزو تظاهرات است):** درسنامه به وضوح بیان می کند که **یووئیت** و IBD ممکن است با آرتریت پسوریاتیک همراه باشند.

- **گزینه ج (غلط - می‌تواند مرتبط باشد):** نارسایی آئورت به عنوان یک عارضه دیررس اسپوندیلو آرتريت محوری ذکر شده است. از آنجایی که بیماران PSA نیز می‌توانند درگیری محوری داشته باشند، این عارضه اگرچه نادر است، اما در طیف عوارض خانواده SpA (که PSA عضوی از آن است) قرار می‌گیرد.
- **گزینه د (غلط - می‌تواند مرتبط باشد):** کلاپینگ مستقیماً در درسنامه به عنوان تظاهر PSA ذکر نشده است. اما کلاپینگ می‌تواند با بیماری التهابی روده (IBD) همراه باشد و IBD نیز با PSA مرتبط است. بنابراین یک ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. در مقایسه با نفرس که یک بیماری کاملاً متفاوت است، این گزینه ارتباط دورتری دارد اما کاملاً بی‌ارتباط نیست.

در میان گزینه‌ها، نفرس به طور قطعی یک بیماری مجزا است و جزئی از تظاهرات PSA محسوب نمی‌شود.

سوال ۲۳

سوال: آقای 35 ساله ای به علت درد و تورم زانوی چپ، مچ دست راست و تورم کل انگشت شماره دو پای راست مراجعه نموده است. بیمار از درد التهابی کمر نیز شاکی است و در معاینه حساسیت ساکروایلیاک دوطرف دارد. با توجه به اطلاعات داده شده کدام تشخیص برای بیمار کمتر مطرح است؟ الف) آرتريت انتروپاتیک ب) آرتريت راکتیو ج) آرتريت روماتوئید د) آرتريت سوریاتیک

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **گزینه ج (صحیح - کمترین احتمال):** شرح حال بیمار (آرتريت نامتقارن، درگیری مفاصل بزرگ و کوچک، داکتیلیت یا "انگشت سوسپسی" در پا، و کمردرد التهابی با حساسیت ساکروایلیاک) یک تابلوی کلاسیک برای اسپوندیلوآرتريت (SpA) است. در مقابل، الگوی مشخصه آرتريت روماتوئید (RA)، پلی‌آرتريت (درگیری مفاصل متعدد) متقارن است که عمده‌تاً مفاصل کوچک دست و پا (MCP/PIP) را درگیر می‌کند. بنابراین، آرتريت روماتوئید کمترین احتمال را در این بیمار دارد.
- **گزینه‌های الف، ب، د (غلط - احتمالات بالا):** آرتريت انتروپاتیک (مرتبط با IBD)، آرتريت راکتیو و آرتريت پسوریاتیک همگی از اعضای خانواده SpA هستند و می‌توانند با الگوی بالینی توصیف شده (الیگوآرتريت نامتقارن، داکتیلیت و ساکروایلیت) تظاهر کنند.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: افتراق الگوی مفصلی SpA از RA): یکی از مهارت‌های اصلی در روماتولوژی، افتراق الگوهای مختلف آرتريت التهابی است. اسپوندیلو آرتريت و آرتريت روماتوئید دو الگوی کلاسیک و متفاوت دارند.

ویژگی	اسپوندیلوآرتريت (SpA)	آرتريت روماتوئید (RA)
تقارن	معمولاً نامتقارن (Asymmetric) است.	معمولاً متقارن (Symmetric) است.

تعداد مفاصل	اغلب الیگوآرتیکولار (درگیری ۴ مفصل یا کمتر) است.	اغلب پلی‌آرتیکولار (درگیری بیش از ۴ مفصل) است.
مفاصل درگیر	عمدتاً مفاصل بزرگ اندام تحتانی (مانند زانو و مچ پا).	عمدتاً مفاصل کوچک دست و پا (MCP, PIP).
درگیری محوری	شایع است (ساکروایلئیت و اسپوندیلیت).	درگیری ستون فقرات به جز مهره‌های گردنی نادر است.
انتزیت/داکتیلیت	شایع و مشخصه بیماری است.	وجود ندارد.
مارکرهاي سرمی	RF و ندول منفی است (به همین دلیل به آنها سرونکاتیو می‌گویند).	RF و Anti-CCP اغلب مثبت هستند.

سوال ۲۴

سوال: در مورد درگیریهای مفصلی آرتریت پسوریازیسی کدام درست است؟

الف) درگیری مفاصل ساکروایلپاک به صورت دوطرفه و قرینه می دهد.

ب) شایع ترین نوع درگیری مفصلی الیگو ارتیکولار غیر قرینه می باشد.

ج) درگیری مفصل DIP دیده نمیشود.

د) درگیری اندام فوقانی نادر است.

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

• **گزینه ب (صحیح):** فایل درسنامه بیان می‌کند که "به طور معمول، PSA در مراحل اولیه به صورت الیگوآرتیکولار (و

اغلب نامتقارن) است و با افزایش تعداد مفاصل درگیر، بیماری پلی‌آرتیکولار شده و توزیع آن متقارن‌تر می‌شود".

- **گزینه الف (غلط):** اگرچه درگیری ساکروایلیاک در PSA رخ می‌دهد، اما الگوی آن اغلب نامتقارن است که یکی از راه‌های افتراق آن از اسپوندیلیت آنکیلوزان کلاسیک (که معمولاً متقارن است) می‌باشد.
- **گزینه ج (غلط):** این عبارت کاملاً نادرست است. درسنامه تأکید می‌کند که "درگیری مفصل DIP (بند انگشتی دیستال) برای PSA تیپیکال است".
- **گزینه د (غلط):** درگیری اندام فوقانی در PSA نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار شایع است. علائمی مانند داکتیلیت انگشتان دست و آرتریت مفاصل دست (DIP, PIP) از تظاهرات کلیدی این بیماری هستند.

توضیح کامل و نکته‌ای (درسنامه: الگوهای درگیری مفصلی در آرتریت پسوریاتیک): آرتریت پسوریاتیک (PSA) به دلیل تنوع بسیار زیاد در تظاهرات بالینی شناخته می‌شود. الگوهای کلاسیک درگیری مفصلی آن عبارتند از:

1. **الگو آرتریت نامتقارن:** این شایع‌ترین الگو در شروع بیماری است که کمتر از ۵ مفصل را به صورت غیرقرینه درگیر می‌کند.
2. **پلی‌آرتریت متقارن:** این الگو می‌تواند بسیار شبیه به آرتریت روماتوئید باشد، اما معمولاً RF منفی است و ممکن است مفاصل DIP را نیز درگیر کند که در RA نادر است.
3. **درگیری غالب مفاصل DIP:** این الگو بسیار مشخصه PSA است و اغلب با تغییرات پسوریاتیک در ناخن‌های همان انگشتان همراه است.
4. **آرتریت موتیلان (Arthritis Mutilans):** شدیدترین و مخرب‌ترین فرم بیماری که با تحلیل شدید استخوان (استئولیز) و کوتاه شدن انگشتان همراه است.
5. **اسپوندیلیت (درگیری محوری):** درگیری ستون فقرات و مفاصل ساکروایلیاک که می‌تواند همراه با هر یک از الگوهای محیطی فوق باشد و اغلب الگوی نامتقارن دارد.

سوال ۲۵

سوال: آقای ۲۶ ساله به علت درد و تورم زانوی راست، مچ پای چپ و هیپ راست مراجعه کرده است. سابقه عفونت ادراری را ۳ هفته قبل از شروع علائم مفصلی ذکر میکند. در معاینه علاوه بر آرتریت مفاصل فوق، تندرns در محل اتصال تاندون آشیل سمت راست به استخوان پاشنه دارد. همه موارد زیر در مورد این بیماری صحیح است به جز؟

(الف) علائم عمومی مثل تب، خستگی، ضعف و کاهش وزن در این بیماری شایع هست.

(ب) کشت مایع مفصل در این بیماری منفی است.

(ج) راش پوسچولر و کراتولیک کف دست و پا دیده میشود.

(د) یوئیت حاد قدامی شایع هست.

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی: شرح حال بیمار (الیگوآرتریت نامتقارن اندام تحتانی به همراه انتزیت تاندون آشیل، ۳ هفته پس از عفونت ادراری) کاملاً با تشخیص **آرتریت واکنشی** مطابقت دارد.

- **گزینه ب (صحیح است):** درسنامه در تعریف آرتریت واکنشی تاکید می‌کند که عامل میکروبی محرک، از مفصل درگیر قابل کشت نیست.
- **گزینه ج (صحیح است):** راش پوستولر و کراتولیک در کف دست و پا، همان **کراتودرما بلنوراژیکا (keratoderma blenorrhagica)** است که به عنوان یکی از ضایعات مخاطی-پوستی در آرتریت واکنشی ذکر شده است.
- **گزینه د (صحیح است):** **یوویت/کونژنکتیویت** به عنوان یکی از تظاهرات خارج مفصلی آرتریت واکنشی در درسنامه آمده است.
- **گزینه الف (صحیح نیست):** فایل درسنامه ارائه شده، در بخش آرتریت واکنشی به علائم اسکلتی-عضلانی و مخاطی-پوستی تمرکز کرده و اشاره‌ای به **شایع بودن علائم عمومی** مانند تب، خستگی و کاهش وزن نکرده است. در حالی که سه گزینه دیگر به طور مستقیم در متن تایید شده‌اند، این گزینه توسط متن پشتیبانی نمی‌شود و بنابراین، گزینه‌ای است که "صحیح نیست".

سوال ۲۶

سوال: کدام یک از تظاهرات رادیولوژیک زیر کاراکتریستیک (مشخصه) اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها می باشد؟

الف) شکل گیری سپین دسموفیت

ب) کاهش فاصله مفصلی

ج) ژوکستا ارتیکولار استئوپنی (پوکی استخوان کنار مفصلی)

د) استئوفیت فورمیشن (تشکیل استئوفیت)

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **گزینه الف (صحیح):** **تشکیل سندسوموفیت** یکی از ویژگی‌های بارز و مشخصه اسپوندیلوآرتريت محوری در مراحل پیشرفته است. سندسوموفیت‌ها پل‌های استخوانی عمودی و ظریفی هستند که بین مهره‌ها ایجاد شده و منجر به محدودیت حرکتی و در نهایت نمای "ستون فقرات بامبو" می‌شوند.
- **گزینه ب و ج (غلط):** کاهش فاصله مفصلی و پوکی استخوان کنار مفصلی، یافته‌های بسیار شایع در **آرتریت روماتوئید (RA)** هستند.
- **گزینه د (غلط):** تشکیل استئوفیت (زوائد استخوانی افقی و خشن) مشخصه اصلی **استئوآرتریت (آرتروز)** است. درسنامه به طور مشخص سندسوموفیت‌های عمودی در SPA را از استئوفیت‌های افقی در آرتروز متمایز می‌کند.

سوال: در مورد بیماری Ankylosing Spondylitis کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) دانسیته مهره ها و فمور در طول بیماری حفظ خواهد شد.

ب) شایع ترین عارضه خارج مفصلی در این بیماری نارسایی آئورت می باشد.

ج) التهاب کولون و ایلئوم در این بیماران همراه با علائم بالینی روده ای می باشد.

د) سینوویت محیطی در این بیماران واسکولاریتی قابل توجه نشان می دهد.

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- **گزینه د (صحیح):** اسپوندیلیت آنکیلوزان یک بیماری التهابی است. درگیری مفاصل محیطی (که در ۳۰-۴۰٪ بیماران رخ می دهد) به صورت آرتریت التهابی محیطی است. ماهیت التهاب مفصلی (سینوویت)، پرخونی و افزایش عروق (واسکولاریتی) در بافت سینوویال است. بنابراین این عبارت از نظر پاتوفیزیولوژیک صحیح است.
- **گزینه الف (غلط):** این عبارت نادرست است. درسنامه به وضوح بیان می کند که "پوکی استخوان (Osteoporosis) یک عارضه شایع است" که می تواند ۴۰٪ بیماران را درگیر کند. این یعنی دانسیته استخوان نه تنها حفظ نمی شود، بلکه کاهش نیز می یابد.
- **گزینه ب (غلط):** شایع ترین عارضه خارج مفصلی، یووئیت قدامی حاد است که در ۴۰٪ بیماران دیده می شود. نارسایی آئورت یک عارضه دیررس و بسیار کمتر شایع است.
- **گزینه ج (غلط):** این عبارت نادرست است. درسنامه ذکر می کند که اگرچه ۱۰٪ بیماران به بیماری التهابی روده (IBD) واضح مبتلا هستند، اما "شواهد بافتی از التهاب تحت بالینی (subclinical) روده در تا ۵۰٪ بیماران دیده می شود". "تحت بالینی" به معنای التهاب بدون علائم بالینی واضح است.